ENFERMEDAD DE ANO Y RECTO

DR. EDGARDO ARCIA

CARCINOGÉNESIS
- Proceso de múltiples pasos con acúmulo de cambios genéticos y epigenéticos a lo largo del tiempo.
- 3 vías moleculares: inestabilidad cromosómica, inestabilidad de microsatélites y fenotipo metilador.

EPIDEMIOLOGÍA
- Global: ~1,8 millones de casos (3.º; 60% colon, 40% recto) y ~881 mil muertes (2.º en mortalidad).
- Panamá 2023: 4.º en incidencia y 1.º en mortalidad por cáncer; 10% de las muertes por cáncer y 50% de diagnósticos avanzados.

FACTORES DE RIESGO
- Edad avanzada: el factor de riesgo más importante.
- Dieta proinflamatoria: carnes rojas y procesadas (aminas heterocíclicas, hidrocarburos policíclicos).
- Disbiosis del microbioma: proliferación de bacterias procancerígenas.
- Diferencias socioeconómicas y subregistro diagnóstico.

PREVENCIÓN
- Colonoscopias regulares desde los 50 años, o antes si hay factores de riesgo.
- Vacunación contra el VPH (reduce el riesgo de cáncer de ano).
- Dieta balanceada, ejercicio regular y evitar tabaco y alcohol.

TAMIZAJE
- Pruebas en heces: sangre oculta a base de guayaco (anual), inmunohistoquímica fecal (anual), ADN fecal (cada 3 años).
- Pruebas estructurales: rectosigmoidoscopia flexible (cada 5 años), colonografía por TC (cada 5 años), colonoscopia (cada 10 años, la de referencia).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
- Cambio del hábito intestinal, sangrado rectal, anemia ferropénica, dolor abdominal y pérdida de peso.
- Muchos pacientes están asintomáticos en etapas tempranas, de ahí la importancia del tamizaje.

DIAGNÓSTICO
- Sospecha clínica → estudios fecales e imágenes → colonoscopia con biopsia.
- El adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente.

ESTADIFICACIÓN
- TNM de la AJCC (8.ª edición): guía el tratamiento y el pronóstico.

BACTERIAS PROCANCERÍGENAS
- La disbiosis favorece bacterias procancerígenas: Fusobacterium, Streptococcus gallolyticus, Bacteroides fragilis (enterotoxina) y Enterococcus faecalis.


Fisura anal


Fistula anal


Plexos hemorroidales internos y externo

ENFERMEDAD DE ANO Y RECTO

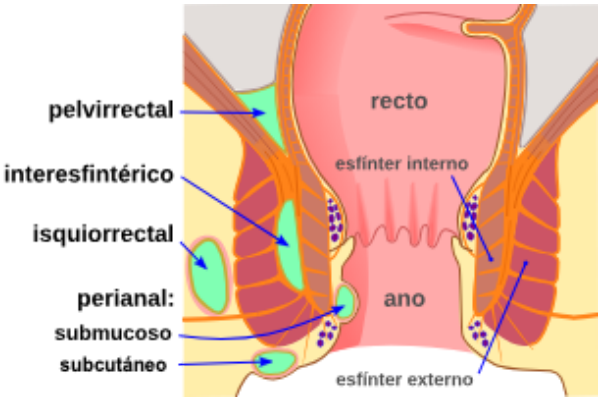
DR. EDGARDO ARCIA

HEMORROIDES INTERNAS
- Venas inflamadas dentro del recto.
- Generalmente no son dolorosas, pero pueden causar sangrado.

HEMORROIDES EXTERNAS
- Bajo la piel alrededor del ano.
- Pueden ser dolorosas, sobre todo si se forma un coágulo.

FISURA ANAL
- Pequeña grieta o desgarro del revestimiento del ano.
- Dolor severo y sangrado durante las evacuaciones.
- Puede ser aguda (corta duración) o crónica (larga duración).

ABSCESO ANAL
- Acumulación de pus en el ano o el recto debida a una infección.

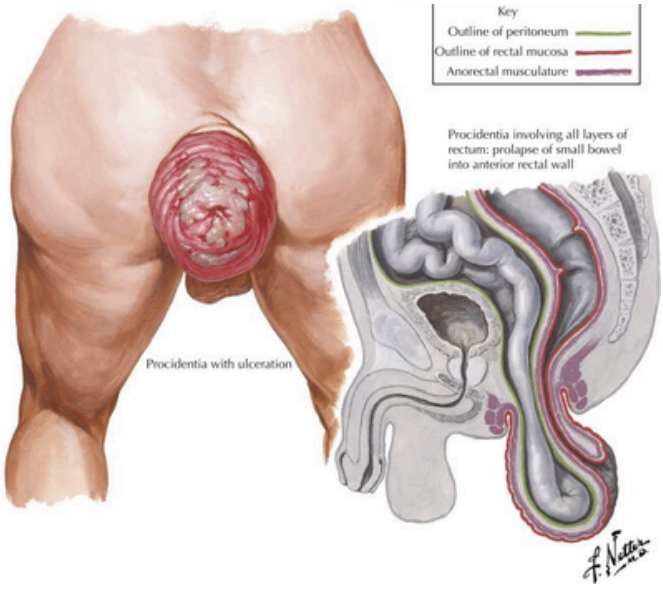


FÍSTULA ANAL
- Túnel pequeño entre el final del intestino y la piel cerca del ano.
- Generalmente resulta de un absceso anal que no sanó correctamente.

CONDILOMAS ANALES
- Verrugas anales causadas por el virus del papiloma humano (VPH).
- Pueden causar picazón, sangrado y malestar.



PROLAPSO RECTAL
- Una parte del recto se desliza y sale por el ano.
- Ocurre en grados variables; puede requerir cirugía en casos severos.



ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
- Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn: pueden afectar cualquier parte del tubo digestivo, incluidos el ano y el recto.
- Inflamación, úlceras, dolor abdominal, diarrea y sangrado rectal.

INCONTINENCIA FECAL
- Incapacidad de controlar las evacuaciones, con fuga involuntaria de heces.
- Por daño de los músculos anales o problemas neurológicos.

DIAGNÓSTICO ANORRECTAL
- Examen físico y, según el caso, anoscopia, sigmoidoscopia o colonoscopia.

TRATAMIENTO ANORRECTAL
- Varía según la condición: desde cambios en la dieta y medicamentos hasta procedimientos quirúrgicos.